

Estrés crónico: evaluación e intervención

Marco clínico para profesionales de salud mental

MODELO TRANSACCIONAL DEL ESTRÉS (LAZARUS & FOLKMAN)

El estrés resulta de la evaluación cognitiva de una demanda como superior a los recursos disponibles. La intervención apunta tanto a la evaluación primaria (percepción de amenaza) como a la secundaria (percepción de recursos de afrontamiento).

EVALUACIÓN CLÍNICA: ÁREAS A EXPLORAR

Estresores

Tipo (laborales, relacionales, económicos, de salud), cronicidad, acumulación.

Afrontamiento

Centrado en el problema vs. en la emoción. Evitativo vs. activo.

Síntomas

Somáticos, cognitivos, emocionales, conductuales. Descartar comorbilidad.

Recursos

Red de apoyo, autoeficacia percibida, habilidades previas de manejo.

Factores de riesgo

Burnout, duelo, trauma subyacente, perfeccionismo, baja tolerancia a la incertidumbre.

INTERVENCIONES CON EVIDENCIA

MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)

8 semanas. Evidencia sólida en reducción de cortisol, sintomatología ansiosa y rumiación. Kabat-Zinn, 1990.

TCC

Reestructuración de evaluaciones cognitivas. Entrenamiento en resolución de problemas. Manejo del tiempo y límites.

ACT

Especialmente útil cuando el estrés es sobre situaciones incontrolables. Aceptación, defusión, valores.

Activación conductual + higiene del sueño

Intervención sobre estilo de vida. Movimiento, sueño, conexión social como variables moduladoras del cortisol.

Intervención en el entorno

Cuando el estresor es modificable: trabajo con habilidades de comunicación asertiva, establecimiento de límites, delegación.

■ Clave clínica:

Distinguir estrés agudo de crónico y burnout. En estrés crónico con síntomas somáticos, coordinar con médico clínico. El autocuidado del terapeuta es parte del modelo: el estrés es contagioso en el vínculo terapéutico.